

· 药物不良反应 ·

奥美拉唑与其他药物相互作用及不良反应

杨欣

【关键词】 奥美拉唑; 药物相互作用; 不良反应

【中图分类号】 R 975 【文献标识码】 B 【文章编号】 1674-3296(2013)01A-0084-01

奥美拉唑是一种能有效抑制胃酸分泌的质子泵抑制剂,与其他药物合用可能产生多种不良反应^[1]。笔者总结了奥美拉唑与其他药物合用的相互作用及不良反应,现报道如下。

1 与其他药物的相互作用

1.1 与抗菌药物合用 胃酸和幽门螺杆菌(Hp)感染是溃疡病的两大攻击因子,由于Hp可深藏于腺体隐窝内,单用奥美拉唑或抗菌药物治疗效果较差,Hp的根除率低。奥美拉唑与对Hp敏感的抗菌药物合用治疗Hp感染可呈协同作用,但在选择与抗菌药物合用时需注意pH值的影响。奥美拉唑能选择性抑制壁细胞膜 H^+-K^+-ATP 酶,阻断胃酸分泌的最终步骤,产生显著的抑制酸分泌作用。服用后胃内pH值明显升高,奥美拉唑每天20mg可使胃内 $pH \geq 3$ 维持16~18h,高时可达pH8左右。四环素在碱性环境下,呈难溶性游离型四环素,不易吸收,使血药浓度下降。匹氨西林是氨苄西林的酯化物,酸性环境下才能吸收完全,且在体内被酯酶分解成氨苄西林而起作用。其生物利用度比氨苄西林高60%,奥美拉唑造成的低酸环境使其非分子型药物增多,脂溶性降低,同时酯结构受到破坏,影响吸收。其他氨苄西林酯或羧苄西林酯也受到pH值的影响。酮康唑的吸收依赖于足够的胃酸分泌,而影响奥美拉唑的抑酸作用,使酮康唑的吸收减少,血药浓度下降。故奥美拉唑不宜与上述抗菌药物合用。

1.2 与地高辛合用 奥美拉唑造成的低酸环境,使地高辛分解为活性较低、药效维持较短的代谢物,严重影响其治疗效果,且奥美拉唑停用后7~10d胃酸分泌才能正常,故奥美拉唑服药期间及停药后一段时间不宜应用地高辛。

1.3 与苯二氮䓬类药物合用 吸烟成年患者2例,使用三唑仑、劳拉西泮或氟西泮期间,给予奥美拉唑每天20mg致步态紊乱,停用苯二氮䓬类药物或奥美拉唑后即很快恢复正常。健康受试者8名每天服用奥美拉唑40mg,1周后可使单剂量静脉注射地西泮(每天0.1mg)的清除率降低54%。另一研究则表明奥美拉唑(每天10mg)可使地西泮清除率减少27%。奥美拉唑与苯二氮䓬类合用代谢有关的酶,而使该类药及其代谢物聚集。利用肝微粒体酶体外研究表明,奥美拉唑与咪达唑仑合用可能也有类似的相互作用。

1.4 与铁剂合用 铁剂的吸收依赖于胃酸的存在, Fe^{3+} 在胃酸的作用下转变为 Fe^{2+} 才被吸收,奥美拉唑的抑酸作用影响铁剂的吸收,故不宜合用。

1.5 与胰酶合用 奥美拉唑的强大抑酸效力,可阻止胰酶在胃中分解,提高了胰酶在小肠中的生物利用度,使疗效增强。有报道,两者合用对囊性纤维化患者难治性脂肪腹泻及小肠广泛切除术后的功能性腹泻有较好的疗效。

1.6 与维生素类合用 奥美拉唑抑制胃酸分泌后,胃内细菌生长,菌群发生明显变化,细菌总量显著增加,致使亚硝酸盐转变为致癌性的亚硝胺,同时服用维生素C或维生素E,有可能限制亚硝胺化合物的形成。食物蛋白结合维生素 B_{12} 的吸收及释出需酸和胃蛋白酶,奥美拉唑的抑酸作用导致蛋白结合维生素 B_{12} 吸收不良。长期应用奥美拉唑会导致维生素 B_{12} 缺乏症,应及时补充适量维生素 B_{12} 。

1.7 与缓释制剂合用 口服缓释或控释制剂其基质控释系统受pH值的影响较大,奥美拉唑造成偏碱性环境,使其缓释及控释系统受到破坏,使主药溶出加快,药理作用增强,并失去长效缓释作用,一般不主张合用。如需合用要特别注意基质的性质。

2 奥美拉唑的不良反

2.1 胃肠道反应 胃肠道反应主要表现为腹痛、腹泻、便秘、腹胀、恶心、口干等。此外长期应用引起胃内细菌过度生长,亚硝酸盐和N-亚硝酸盐均明显增加,血浆胃泌素水平亦明显升高。越来越多的研究证明亚硝基化合物极可能是人类癌症的一类重要致癌物,而细菌在胃内生长,可促进亚硝基化合物的合成。同时,胃泌素有促进致癌剂的作用,在使用亚硝基化合物诱发胃癌的同时给予胃泌素,胃癌的发生率将明显增加。给大白鼠大剂量的奥美拉唑2年可引起肠嗜铬样(enterochromaffin-like,ECL)细胞增生和胃类癌。

2.2 对肝脏的损害 主要表现为血清丙氨酸氨基转移酶(ALT)与血清天冬氨酸氨基转移酶(AST)暂时性的升高。国外曾报道1例62岁患者,因糜烂性食管炎服奥美拉唑17d,引起暴发性肝功能衰竭而死亡。同时奥美拉唑可抑制肝内 P_{450} 细胞色素氧化酶,影响某些药物代谢,并延长地西泮、苯妥英、氨基比林等药物的清除半衰期,从而延长药物的排泄,这可能与奥美拉唑主要在肝脏代谢后排出有关。因此肝功能低下的患者慎用。

2.3 对肾脏的损害 主要表现为血肌酐升高和血尿、尿闭。有报道2例老年妇女应用奥美拉唑后出现肾功能不全,经肾穿活检证实为典型的急性间质性肾炎,其机理尚不清楚。奥美拉唑在肝脏完全代谢后80%以代谢产物的形式从尿中排出,可能由其代谢产物影响肾脏的排泄功能所致。故老年人或肾功能不全患者应用时应注意肾功能的变化。

2.4 对神经系统的损害 主要表现为头痛、头昏、头晕、失眠、疲倦、嗜睡、神志改变、指端麻木等。尚有报道奥美拉唑治疗溃疡病出现先前存在的焦虑、抑郁加重和头痛、胸闷。

参考文献

- 1 刘建梅,王筱君,王玉文.注射用奥美拉唑与氨甲苯酸、酚磺乙胺存在配伍禁忌[J].临床误诊误治,2011,24(12):99.